

Otitis media serosa (otitis secretora)

1. Introducción y relevancia clínica

La **otitis media serosa (OMS)**, también conocida como **otitis media con efusión** u **otitis secretora**, corresponde a la **presencia persistente de líquido no purulento en la cavidad del oído medio**, sin signos agudos de infección.

Es el resultado de una **disfunción de la trompa de Eustaquio**, que impide la adecuada ventilación y drenaje del oído medio.

A diferencia de la otitis media aguda, **no hay dolor, fiebre ni abombamiento timpánico**, pero sí **hipoacusia conductiva** y sensación de oído tapado.

Es una causa muy frecuente de **hipoacusia infantil leve**, y en adultos puede reflejar una **obstrucción nasofaríngea** (como un carcinoma de cavum).

Relevancia clínica:

- En **niños menores de 6 años**, puede afectar el desarrollo del **lenguaje y aprendizaje** si es persistente.
- Representa hasta el **70% de las otitis medias residuales** post-OMA.
- Es una causa común de **consulta otorrinolaringológica** en APS y colegios.
- En adultos, su aparición unilateral obliga a descartar una **masa nasofaríngea**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La OMS se produce por un **desequilibrio entre la producción y reabsorción de líquido en el oído medio**, secundario a una **ventilación ineficiente** de la trompa de Eustaquio.

2.1 Mecanismo fisiopatológico

1. **Disfunción tubárica** (por inflamación o bloqueo mecánico).
2. Presión negativa en oído medio → **retracción de la membrana timpánica**.

3. Transudación de líquido seroso o mucoso desde la mucosa timpánica.
4. Acumulación de secreción viscosa sin infección bacteriana activa.

2.2 Factores predisponentes

Grupo	Factores
Niños	Hipertrofia adenoidea, infecciones respiratorias recurrentes, alergia, hendidura palatina, reflujo gastroesofágico
Adultos	Sinusitis crónica, tabaquismo, barotrauma, masas nasofaríngeas (carcinoma)
Generales	Disfunción tubárica crónica, exposición a humo ambiental, historia de OMA recurrente

2.3 Tipos de líquido en el oído medio

- **Seroso:** claro, fluido, escaso.
 - **Mucoso:** más espeso, amarillento, viscoso ("glue ear").
 - **Hemorrágico:** en barotrauma o trauma timpánico.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

Síntoma	Características
Hipoacusia conductiva leve a moderada	Fluctuante, bilateral o unilateral.

Sensación de oído tapado / plenitud	Sin dolor ni fiebre.
Autofonía	El paciente percibe su propia voz más resonante.
Tinnitus leve o burbujeante	Asociado al movimiento del líquido.
Antecedente de OMA reciente o alergia nasal	Frecuente.

En niños, los padres suelen notar:

- Retraso del lenguaje.
- Disminución del rendimiento escolar.
- Distracción o “no escucha”.

3.2 Signos al examen físico (otoscopía)

Hallazgos característicos:

- **Membrana timpánica retraída**, opaca o con color amarillento-grisáceo.
- **Nivel hidroaéreo** o burbujas visibles detrás del tímpano.
- Disminución o abolición de la movilidad timpánica (otoscopía neumática).
- Sin eritema ni abombamiento.

En casos crónicos:

- Engrosamiento timpánico.
- Atelectasia timpánica (retracción severa hacia el promontorio).
- Tímpano esclerosado (timpanoclerosis).

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Otitis media aguda	Fiebre, dolor intenso, tímpano abombado y opaco
Hipoacusia neurosensorial	Audiometría muestra pérdida en tonos altos, sin efusión
Otitis adhesiva crónica	Retracción timpánica severa y adherencias
Colesteatoma	Otorrea crónica, masa blanquecina en oído medio
Barotrauma	Antecedente de vuelo o buceo; hemotímpano o dolor súbito

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico (según guías MINSAL y AAO-HNS)

El diagnóstico se confirma con **dos o más de los siguientes hallazgos**:

1. Presencia de líquido o burbujas detrás de la membrana timpánica.
 2. Movilidad disminuida o abolida (otoscopía neumática o timpanometría).
 3. Tímpano opaco o retraído.
 4. Hipoacusia conductiva leve (audiometría).
 5. Ausencia de signos de infección aguda (sin fiebre ni dolor intenso).
-

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Timpanometría (tipo B)	Patrón diagnóstico: curva plana sin pico de presión
Audiometría tonal liminar	Hipoacusia conductiva leve (20–40 dB)
Nasofibroscopía	En adultos o recurrencia unilateral: descartar obstrucción nasofaríngea
TAC de cavidades nasosinusales	Si se sospecha patología sinusal o anatómica
Evaluación alérgica / RGE	En cuadros recurrentes

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo depende de la **edad, duración, severidad de la hipoacusia** y presencia de **factores predisponentes**.

5.1 Conducta inicial (observación activa)

La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente.

- **Observación durante 3 meses** (OMS / MINSAL):
 - Control clínico y audiométrico.
 - Manejo de factores asociados (rinitis, alergia, adenoiditis).
 - Evitar antibióticos o corticoides sistémicos de rutina (no demuestran beneficio sostenido).
-

5.2 Tratamiento médico

Indicaciones:

- OMS persistente (>3 meses).
- Hipoacusia >25 dB.
- Factores de riesgo (lenguaje, rendimiento escolar, síndrome de Down, hendidura palatina).

Opciones terapéuticas:

1. Corticoides nasales tópicos:

- Budesonida, fluticasona o mometasona, 1–2 puff por fosa/día (4–6 semanas).
- Útiles si hay componente alérgico o rinitis crónica.

2. Antihistamínicos / descongestionantes:

- No recomendados de rutina (efectividad limitada).

3. Tratamiento de rinitis o sinusitis concomitante.

5.3 Tratamiento quirúrgico

Indicaciones:

- OMS persistente >3 meses con hipoacusia significativa.
- Retraso del lenguaje o aprendizaje.
- Atelectasia timpánica progresiva.
- Episodios recurrentes (>3 por año).

Procedimientos:

1. Miringotomía con aspiración de líquido.
2. Colocación de tubos de ventilación transtimpánicos (diabolo).

- Permite ventilación del oído medio por 6–12 meses.
- Mejora audición y previene recurrencias.

3. Adenoidectomía concomitante:

- En niños >3 años con hipertrofia adenoidea.

5.4 Seguimiento

- Control clínico cada 3–6 meses con timpanometría y audiometría.
- Retiro espontáneo o quirúrgico de tubos según evolución.
- Educación a padres sobre signos de recurrencia.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Retraso del lenguaje y aprendizaje	Por hipoacusia conductiva mantenida
Otitis media adhesiva crónica	Retracción timpánica severa y adherencias
Timpanoclerosis	Engrosamiento timpánico por fibrosis
Perforación timpánica residual	Secundaria a tubos o infecciones
Colesteatoma adquirido	En casos prolongados con retracción timpánica focal

Pronóstico:

- En la mayoría, resolución espontánea en 2–3 meses.
 - En casos tratados con tubos, mejoría auditiva inmediata.
 - Recidivas en 15–20% de los niños, especialmente si persisten factores predisponentes.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La OMS **no cursa con fiebre ni dolor**, pero sí con **hipoacusia conductiva leve**.
 2. En **adultos con OMS unilateral persistente**, siempre descartar **carcinoma nasofaríngeo**.
 3. El diagnóstico se confirma con **timpanometría tipo B** y **otoscopía con nivel hidroaéreo**.
 4. La mayoría se resuelve espontáneamente: **no usar antibióticos empíricamente**.
 5. En **niños con retraso del lenguaje**, considerar tubos de ventilación tempranos.
 6. **Adenoidectomía** mejora significativamente la evolución en casos recurrentes.
-

Errores comunes

- Confundir con OMA y prescribir antibióticos innecesarios.
 - No evaluar audición ni lenguaje en el seguimiento.
 - No investigar causa tumoral en adultos con OMS unilateral.
 - Uso prolongado de descongestionantes o corticoides sistémicos.
 - No derivar a ORL pese a persistencia >3 meses.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **otitis media serosa** es la **presencia de líquido en el oído medio sin infección activa**, causada por **disfunción tubárica**.
2. Se presenta con **hipoacusia conductiva leve, tímpano retraído y movilidad disminuida**.
3. El diagnóstico se confirma con **timpanometría tipo B y audiometría**.
4. La mayoría de los casos **se resuelven espontáneamente** en 2–3 meses.
5. El **tratamiento médico** incluye control de rinitis, corticoides nasales y observación activa.
6. Si la efusión persiste o hay hipoacusia significativa → **colocación de tubos de ventilación**.
7. En **adultos con OMS unilateral**, se debe **descartar carcinoma nasofaríngeo**.